

CAPÍTULO 14.8

Artritis Reumatoide: Clínica y Diagnóstico

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Artritis Reumatoide (AR)** es una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune, que afecta predominantemente a las articulaciones de forma simétrica y erosiva. Es una patología de alta relevancia clínica en Chile y el mundo, afectando aproximadamente al **1% de la población femenina**. Para el examen EUNACOM, es fundamental saber diferenciarla de la **Artrosis** y otras artropatías.

Cuadro Clínico Articular

La manifestación cardinal de la AR es una **poliartritis crónica** (evolución mayor a 6 semanas). Se caracteriza por la presencia de signos inflamatorios evidentes: aumento de volumen, derrame articular, eritema y dolor.

Distribución y Localización

Manos y Muñecas: Son las zonas más frecuentemente afectadas. Las articulaciones "clásicas" son las **metacarpofalángicas (MCF)**, las **interfalángicas proximales (IFP)** y las **muñecas**. **Respeto de Distales:** A diferencia de la **Artrosis**, la AR habitualmente **no afecta** las interfalángicas distales (IFD). **Otras articulaciones:** Rodillas, codos y hombros también se ven comprometidos con frecuencia. **Compromiso Axial:** La AR suele respetar la columna vertebral, **excepto la articulación atlanto-axoidea (C1-C2)**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir estas deformaciones con los **Nódulos de Heberden (IFD)** o **Bouchard (IFP)** propios de la **Artrosis**, los cuales son de consistencia ósea y no inflamatoria.

Diagnóstico y Laboratorio

El diagnóstico de la AR es fundamentalmente **clínico**, apoyado por marcadores de laboratorio y hallazgos radiológicos.

Marcadores Serológicos

1. **Factor Reumatoide (FR):** Sensible pero poco específico (puede elevarse en infecciones o en el envejecimiento). 2. **Anticuerpos Anti-Péptido Citrulinado (Anti-CCP):** Altamente específicos para AR y tienen valor pronóstico. 3. **Reactantes de Fase Aguda:** La **VHS** (Velocidad de Sedimentación) y la **PCR** (Proteína C Reactiva) suelen estar elevadas y reflejan la actividad de la enfermedad.

Radiología

La imagen clásica muestra una **artritis erosiva**. **Erosiones en "saca bocado":** Lesiones óseas marginales causadas por el panus. **Osteopenia yuxta-articular:** Pérdida de densidad ósea en el hueso adyacente a la articulación inflamada. Disminución simétrica del espacio articular.

Criterios Diagnósticos (ACR/EULAR 2010)

Se requiere un puntaje **≥ 6 puntos** para confirmar el diagnóstico:

TABLA 14.8.1: CATEGORÍA VS CRITERIO

CATEGORÍA	CRITERIO	PUNTOS
Compromiso Articular	1 articulación grande	0
	2-10 articulaciones grandes	1
	1-3 articulaciones pequeñas	2
	4-10 articulaciones pequeñas	3
	>10 articulaciones (al menos 1 pequeña)	5
Serología	FR (-) y Anti-CCP (-)	0
	FR (+) bajo o Anti-CCP (+) bajo	2
	FR (+) alto o Anti-CCP (+) alto	3
Reactantes Fase Aguda	VHS y PCR normales	0
	VHS o PCR elevados	1
Duración	< 6 semanas	0
	≥ 6 semanas	1

Rigidez Matinal

Es un síntoma pivote. Para orientar a AR, la rigidez debe durar **más de 30 minutos**, aunque típicamente en pacientes activos supera la hora o incluso las dos horas de duración.

Manifestaciones Extraarticulares y Sistémicas

La AR es una enfermedad sistémica que puede afectar múltiples órganos:

- **Nódulos Reumatoideos:** Son la manifestación extraarticular más frecuente. Se palpan habitualmente en superficies de extensión, como el **codo**.
- **Síntomas Constitucionales:** Fiebre, compromiso del estado general y baja de peso.
- **Pulmón:** Derrame pleural (característicamente con glucosa muy baja) y fibrosis pulmonar.
- **Corazón:** Pericarditis (frecuente), miocarditis o endocarditis autoinmune.
- **Vasos Sanguíneos:** Puede presentarse vasculitis reumatoidea secundaria.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Panus: La inflamación crónica produce una proliferación de la membrana sinovial llamada **panus**. Este tejido invasivo es el responsable de "comerse" el hueso, generando las erosiones óseas características.

Deformaciones en Etapas Avanzadas

En cuadros de larga data o mal controlados, aparecen deformidades características que permiten el diagnóstico clínico visual:

Ráfaga Cubital: Desviación de los dedos hacia el lado cubital (ulnar). **Dedos en Cuello de Cisne:** Hiperextensión de la IFP con flexión de la IFD. **Dedos en Ojal (Boutonnière) o "en Sastre":** Flexión de la IFP con hiperextensión de la IFD.

Diagnóstico Diferencial

Es vital distinguir la AR de otras patologías: **Artrosis:** Dolor mecánico (mejora en reposo), afecta IFD, sin compromiso sistémico ni reactantes elevados. **Artritis Psoriática:** Suele ser asimétrica, afecta IFD y se asocia a lesiones cutáneas. **Artritis Séptica:** Generalmente monoarticular, aguda, con compromiso sistémico severo y líquido articular purulento.

Pronóstico

El pronóstico de la enfermedad se mide por los mismos elementos del diagnóstico: **Clínica:** A mayor número de articulaciones afectadas y mayor discapacidad funcional, peor pronóstico. **Laboratorio:** Títulos

altos de FR y Anti-CCP se asocian a una enfermedad más agresiva y destructiva. **Radiología:** La presencia temprana de erosiones indica una evolución tórpida si no se instauro tratamiento precoz.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas en la artritis reumatoide?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Reumatoide: Clínica y Diagnóstico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- AR: poliartritis crónica de IFP, MCF y muñecas con rigidez matinal >30 minutos
- Es una artritis erosiva por proliferación del tejido sinovial (pannus)
- Manifestaciones extraarticulares: nódulos reumatoideos (los más frecuentes), vasculitis, afectación pulmonar y cardíaca
- Deformaciones tardías: ráfaga cubital, dedos en cuello de cisne, dedos en boutonnière
- Marcadores: factor reumatoide y anti-CCP (más específico)
- Diagnóstico: criterios con puntaje, 6 o más puntos confirman; es fundamentalmente clínico
- Pronóstico: peor con más articulaciones afectadas, más erosiones y marcadores positivos en títulos altos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS REUMATOIDE: CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO)

PREGUNTA 1

¿Cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas en la artritis reumatoide?

- ☐ A) Interfalángicas distales, primera carpometacarpiana y rodillas
- ☐ B) Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y muñecas
- ☐ C) Sacroilíacas y columna lumbar
- ☐ D) Primera metatarsofalángica y tobillos
- ☐ E) Codos y hombros exclusivamente

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes es la manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoide?

- ☐ A) Fibrosis pulmonar
- ☐ B) Vasculitis secundaria
- ☐ C) Nódulos reumatoideos
- ☐ D) Miocarditis
- ☐ E) Síndrome de Sjögren secundario

PREGUNTA 3

Paciente con artritis reumatoide de larga data presenta desviación de los dedos hacia cubital. ¿Cómo se denomina esta deformación?

- ☐ A) Dedos en cuello de cisne
- ☐ B) Dedos en boutonnière
- ☐ C) Nódulos de Heberden
- ☐ D) Ráfaga cubital
- ☐ E) Dactilitis

RESUMEN: ARTRITIS REUMATOIDE: CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

La artritis reumatoide afecta hasta el 1% de las mujeres. Se presenta como poliartritis crónica con signos inflamatorios (derrame articular, eritema, aumento de volumen), afectando principalmente IFP, MCF y muñecas. La rigidez matinal mayor a 30 minutos (frecuentemente más de 1-2 horas) es muy característica. Es una artritis erosiva con proliferación del tejido sinovial (pannus) que destruye el hueso. Las manifestaciones extraarticulares incluyen nódulos reumatoideos, vasculitis secundaria, afectación pulmonar y cardíaca. Las deformaciones tardías son ráfaga cubital, dedos en cuello de cisne y dedos en boutonnière. Los marcadores son factor reumatoide y anti-CCP; los marcadores inflamatorios (VHS, PCR) complementan. El diagnóstico se basa en criterios que incluyen número de articulaciones afectadas, marcadores, inflamación sistémica y duración mayor a 6 semanas. Con 6 puntos o más se confirma. En resumen, el diagnóstico es clínico con apoyo de marcadores.